

Fecha Última Actualización: 19-03-2026 13:04:08

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Jennifer Andrea Tranacán Avendaño **Rut** : 16.032.317-5 **N° Archivo** : 1510306
Edad : 40a 10m 23d **Fecha Nacto**: 24/04/1985 **Sexo** : Femenino
Dirección : Isla Canarias 2239 Villa Los Rios El Molino **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 958382177

N° Epicrisis
475688

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 12/03/2026 02:49 **Días Estadía** : 7
Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía **Fecha Egreso** : 19/03/2026 11:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Estado epiléptico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

40 años, soltera, 4 hijos, educación media completa, comerciante en ferias libre
mRS1

Antecedentes:

Médicos: epilepsia secundaria a TEC diagnosticada en 2020, trastorno por uso de sustancias (THC, OH, Cocaína), hospitalizaciones por crisis epilépticas y trastorno por uso de sustancias. Sin registro de control ambulatorio en Pulso. Sin clara fecha de última crisis.

Quirúrgicos: apendicectomía, colecistectomía

Tabaco: (+) OH: (+) Drogas: cocaína, THC, OH.

Alergias: no

Medicamentos: Ac. Valproico 500 mg c/ 12 h, sertralina 50 mg/ día, Levetiracetam 1 g c/ 12 h, amitriptilina y diazepam suspendidos, mala adherencia a tratamiento

Motivo de consulta:

Refiere suspensión de medicamentos y consumo de sustancia 7-10 días previo al ingreso. Paciente estando en custodia en comisaría presenta episodio de convulsión tónico clónica generalizada presenciada de menos de 1 min de duración, con crisis subintraentes posteriores.

Ingresó a servicio de urgencias con compromiso de conciencia e importante agitación, sin evidencia de estado epileptico sutil. Evaluada por neurología: Sopor profundo. Plantares extensores bilaterales. Sin signos sutiles de estado epileptico. Requirió múltiples dosis de benzodiacepinas y carga con fenitoina intravenosa 1gr. Se realizó TC de cerebro, cextenso foco encefalomalacia en polo temporal anterior y region frontoorbital, sugerente TEC antiguo. Sin evidencia de lesiones agudas.

Por compromiso de conciencia y agitación se decidió intubación orotraqueal e ingreso a UPC.

Evolución en UPC y sala de neurología:

Neurología:

Paciente posterior a ingreso sin evidencia de crisis clínicas.

Se decidió mantener con el siguiente esquema farmacológico:

- Diazepam 10 mg cada 12 horas
- Fenitoina 100 mg AM - 200 mg PM

Fecha Epicrisis : 19/03/2026 13:04

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 19-03-2026 13:04:08

Página 2 de 3

- Levetiracetam 1 g cada 12 horas
- Fenobarbital 100 mg al día

Con buena respuesta clínica, evoluciona favorablemente weaning, logrando ser extubada el 14/03, sin evidencia de nueva focalidad neurológica. Sin nuevas crisis clínicas. Control de niveles de fenitoina 13/3 de 14.3.

Se traslado a unidad de sala neurología el 18/3/26, donde se encontró en basal desde el punto de vista neurológico, sin necesidad de ampliar estudio etiológico dado causa conocida de descompensación. Fue evaluada por fonoaudiología, retirándose sonda nasogástrica. Alimentándose vía oral desde el 17/3, actualmente con regimen sin restricciones. Deambulando con asistencia preventiva con kinesiología.

Otros:
Al ingreso con hiperlactatemia, PCR elevada y leucocitosis, interpretados en contexto de crisis. Se realizó cultivo de aspirado endotraqueal, radiografía de tórax y estudio de orina que no evidenció foco infeccioso. Sin necesidad de antibioticos y con caída espontánea de parámetros. Se mantuvo en observación.
Se mantiene con tiamina 500 mg cada 8 horas por antecedentes y paciente que se observó enflaquecida. Sin evidencias de encefalopatía de Wernicke.
Sin mayores evidencias de privación por TUS, considerando que se mantiene con benzodiacepinas por horario.

Dado buena evolución clínica se decidió alta a domicilio para continuar control de manera ambulatoria.

Diagnósticos de alta:
Estado epileptico yugulado
- Epilepsia estructural descompensada por suspensión de fármacos
Trastorno por uso de sustancias
Antecedentes

Diagnóstico de Egreso

Status Epileptico Convulsivo - Epilepsia Estructural Secuela De Tec
Policonsumo

Síndrome De Dependencia De Cocaína -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Examen neurológico normal.
Sin focalidad neurologica
Vigil, OTE atenta, sin afasia. Sin disartria.
mRS1

Plan Post Alta

Regimen común, consistencia blando sin granos
Reposo relativo
Evitar privación de sueño
No puede conducir vehículos (motorizados ni no motorizados)
Suspender consumo de sustancias (OH, THC cocaína)

Fármacos:
Diazepam 10 mg, 1 comprimido cada 12 horas via oral a permanencia
Fenitoina 100 mg, 1 comprimido AM + 2 comprimidos PM via oral a permanencia
Levetiracetam 1g, 1 comprimido cada 12 horas via oral a permanencia
Fenobarbital 100 mg, 1 comprimido noche via oral a permanencia.

Controles:
Control ambulatorio con neurología en CDT pasillo 9. Se entrega interconsulta
Retirar medicamentos en establecimiento de APS correspondiente. Se entrega interconsulta.
Control en APS para ingreso a programa de rehabilitación de abuso de sustancias

Fecha Epicrisis : 19/03/2026 13:04

Página 2 de 3

Control en servicio de urgencias según indicaciones y síntomas de alarma

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Rosa Ogrodnik Orellana

Médico Tratante (Staff)